جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجاح صلاح عطيه احمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الجمهوريه **العنوان :** ******
رقم البطاقة : 28108051404344 **رقم التليفون :** 01100885838 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 05-08-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجاح صلاح عطيه احمد
National ID: 28108051404344

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



نجاح
صلاح عطيه احمد

الشموت
مركز بنها - القليوبية

٢٨١٠٨٠٥١٤٠٤٣٤٤

LD2941101

National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: نجاح صلاح عطيه احمد	
MR. : 1850	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with a T2 N1, moderately differentiated (GII) invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast, hormone-receptor positive (HR+), HER2 positive, with a Ki-67 proliferation index of 40%. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) was administered with six cycles of the TCHP regimen, the last cycle completed on 14 January 2026. Following NACT, the patient underwent a clipped left-sided wide local excision (WLE) with sentinel lymph node biopsy (SLNB); pathology demonstrated free margins and 0/4 positive sentinel nodes. Multidisciplinary team discussion on 21 June 2026 recommended adjuvant therapy with phesgo for up to 17 cycles, and a referral was made for endocrine therapy with femara and zoladex (extended formulation). The prescription for femara plus zoladex for three months was dispensed on the same day. The patient has completed six cycles of TCHP.

For ongoing management, the patient is receiving phesgo in conjunction with femara and supportive therapy, now at cycle 7 of the phesgo regimen. The patient will also undergo a pre-operative echocardiogram as part of cardiac monitoring. The patient has completed seven cycles of phesgo.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	يمنى امجد خالد		

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / نجاح صلاح عطيه احمد	Request No.	: 13006505
Patient No.	: 28108051404344	Request Date	: 13/05/2026
Path No.	: 1490/26	Verification Date	: 01/06/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.
Nature of Specimen: Left breast conservative surgery & Sentinel lymph nodes biopsy.

Gross Examination:
* Left breast wide local excision specimen measured 08x07 cm, with covering skin ellipse measured 04x02 cm.
* Serialling showed a tumor bed site measured 06x1.5 cm located 0.5 cm away from the least deep margin.
* Sentinel lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 05x05x1 cm, entangling 4 lymph nodes.
* 14 Blocks:
1- Superior margin., 2- Inferior margin., 3 -Lateral margin., 4- Medial margin., 5- Deep margin., 6:12- Wired TBS., 13,14- SLNs.
- Grossing done by; Dr. Heba El-Shafeey.

Microscopic Examination:
* Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Cellularity (0%).
* Angioinvasion: Absent.
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Surgical margins: Free.
* Sentinel lymph nodes: Four lymph nodes free of viable metastatic deposits, LNs (0/4) without therapy effect.
* Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

Diagnosis:
Left breast cancer (Post-NACT), wide local excision & Sentinel lymph nodes biopsy:
- No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نجاح صلاح عطيه احمد	Request No.	: 13006505
Patient No.	: 28108051404344	Request Date	: 13/05/2026
Path No.	: 1490/26	Verification Date	: 01/06/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Surgical margins: Free.
- Sentinel lymph nodes: No metastatic depostis in lymph nodes, (0/4).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.

* Stage: ypT0, ypN0 (sln).

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

06/11/2026

MDT FORM

Name:	Najah Salah Allah Ahmed	**MRN:**	1850
Age:	45 Y	**ID:**	28108051404344
Menopausal Status:	PRE MENOPAUSAL	**Phone:**	01100885838
NRS SCORE:		**Marital Status:**	married
BMI:		**Family History:**	-ve
CO Morbidity:	MEDICALLY FREE	**Reason Of MDT:**	postop

Clinical Data:

BX: IDC GII

ER: 7/8 **PR:** 8/8 **HER2:** +3 **KI67:** 40

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

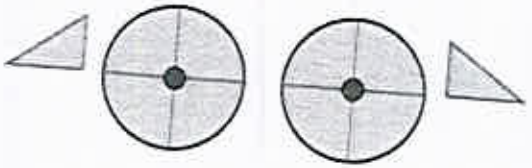
T2 N1 M0
POST NACT TCHP LAST CYCLE 14/1/2026
CLIPPED
then LT WLE + SLNB
free margins
SLNB 0/4

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

DFOR ADJ phesgo up to 17 cycel
PORT
femera/ zoladex extended

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr Hanan Ezzat	Dr Ahmed Naguib				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name: Nagah Salah Atteya Ahmed	Date : 29/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 1925/2025	Pat. ID: 110747

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS:

I Chest:

- No available clinical data.
- **Small nodule at left inner quadrant 12 x11mm.**
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mild enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities .
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals. .
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The examined skeleton show no worrisome lytic or sclerotic bony lesions.

Opinion:

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name: Nagah Salah Atteya Ahmed	Date : 29/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 1925/2025	Pat. ID: 110747

Small nodule at left inner quadrant for dedicated US.
,otherwise unremarkable study

Kindly accept my best wishes;
Dr. Reham Khedr,,MD
Radiology Consultant .
July 29,2025

17/08/2025 3:16 PM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL CANCER

تقرير العينة

Patient Name	: الأستاذه / نجاح صلاح عطيه احمد	Request No.	: 13000838
Patient No.	: 28108051404344	Request Date	: 14/06/2025
Path No.	: 2020/25	Verification Date	: 19/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data
Left breast mass

Nature of specimen
Tru cut biopsy, collected on 12/6/2025, 10:30 am

Gross examination
Multiple grayish white tissue cores up to0.7 cm, totally submitted.
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination
* Histological type: Invasive duct cacinoma
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade 2
* DCIS: No
* Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
*Perineural invasion: No
• IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: Moderate nuclear reaction in 85% tumor cells (Allred score 7/8)
* PR: Strong nuclear reaction in 90 % tumor cells (Allred score 8/8)
* HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)
* Ki 67: 40 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis
Left breast mass, Tru cut biopsy:

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

تقرير العينة

Patient Name	: الأستاذه / نجاح صلاح عطيه احمد	Request No.	: 13000838
Patient No.	: 28108051404344	Request Date	: 14/06/2025
Path No.	: 2020/25	Verification Date	: 19/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade 2
IPT:
* ER: Positive (score 7/8).
* PR: Positive(score 8/8).
* HER2: Positive (score 3+).
* Ki67: Positive in 40% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba Hassan Adly

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Najah Salah Atieh
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Rosch Hospital

Date : 04-08-2025 09:34
Medical No. : 167156

NILE DIAGNOSTIC CENTER

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 43-year-old lady, with left breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Study Date: 20/08/2025 07:00:00 PM	اسم المريض: نجاح صلاح عطيه
الطبيب المعالج: ...	كود المريض: 308973

MAMMOGRAPHIC EXAMINATION WITH COMPLEMENTARY ULTRASOUND FOR LEFT BREAST REVEALED:

Findings :

Pathologically proved left breast cancer shows:

A fairly defined irregular shaped speculated hypoechoic solid mass lesion is seen affecting the lower outer domain of the left breast 4/5 o'clock position, measuring 1.6 x 1.1 cm. It casts posterior acoustic shadowing with internal vascularity.

No signs of inflammation or abscess formation.

No ductectesia.

No micro- or macro-calcifications.

Normal skin thickness and contour.

Normal areola / nipple complex.

Multiple left axillary enlarged lymph nodes are noted showing preserved oval shape and central echogenic hilum.

CONCLUSION:-

Left breast pathologically proven malignant mass lesion (BIRADS VI).

Much Obliged, Yours

Dr. Haitham Alshaikh, MSc

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

[[DOCTYPE:ECHO]]
echo

AO	2.7	cm	LVESD	2.9	cm
LA	3.6	cm	LVEDD	4.8	cm
IVS	0.7	cm	EF	68%	
PW	0.8	cm	RV		

Comments:

- Normal LV internal dimensions with good LV systolic function (EF=68% by M-mode method).
- No RWMA could be detected at rest.
- Normal MV leaflets with trivial mitral regurge.
- Normal AV leaflets with normal flow signal.
- Normal TV leaflets with mild tricuspid regurge and no significant pulmonary hypertension (estimated PASP=15mmHg).
- Intact IAS and IVS at level of TTE.
- Normal pericardium with no effusion.
- No intra-cavitary masses or thrombi.

Conclusion:

- **Within normal Echo-Doppler study.**

Best regards,

Dr. Maged Khaled

MD cardiology

IAS INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

IAS ACCREDITED

Head Office :
Benha - Kalubia
Tel: 013 322 3222 - Mob : 010 2225 0359
Benha Branch 2
Tel : 0133 221020 - Mob : 010 222 50 359
kafr shok Branch :
Tel : 013/2529988
Al-Monofya - Estanha branch
Tel : 048 386 555 6

المركز الرئيسي : القليوبية - بنها
ت : ٠١٣٢٢٢٣٢٢٢ - موبيل : ٠١٠٢٢٢٥٠٣٥٧
فرع بنهـــا ٢ :
ت : ٠١٣٢٢٢١٠٢٠ - موبيل : ٠١٠٢٢٢٥٠٣٥٩
فرع كفر شكر :
ت : ٠١٣٢٥٢٩٩٨٨